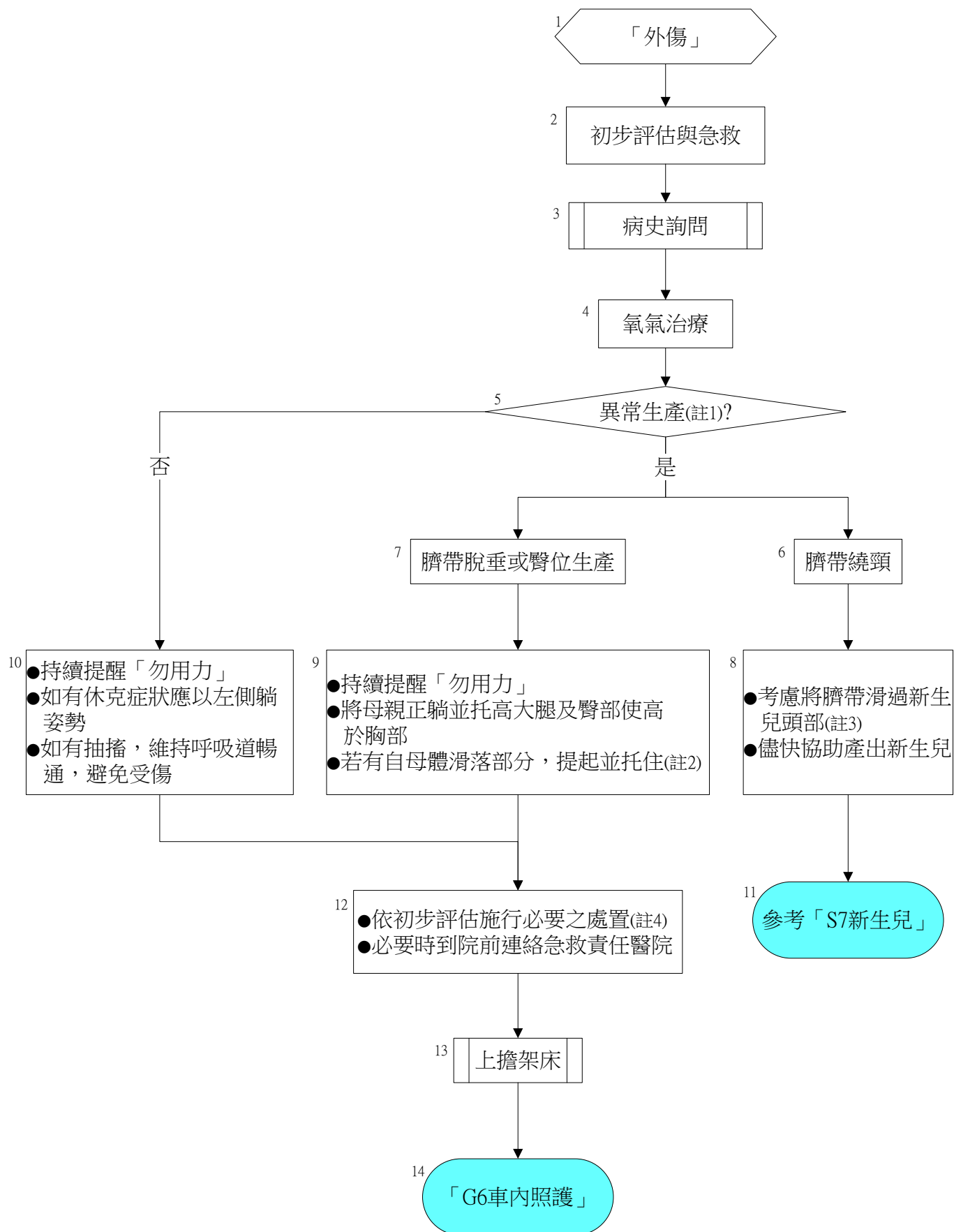


S6 產科急症

程 序



要 旨

- 一、懷孕24週至生產期間孕婦發生的急症即建議使用本程序。
- 二、如懷孕20週以下之孕婦，所產出之嬰兒存活機率微小，如產出請參考「S7新生兒」處置。

註 解

註1>

異常生產係指發現臍帶脫垂、臍帶繞頸或臀位生產。

- 一、臍帶脫垂：是指羊膜破裂後，臍帶滑脫至胎兒先露部位的前端，位於子宮頸口或陰道內。
- 二、臍帶繞頸：臍帶常會纏繞住胎兒身體的一部分，尤其是頸部，此時就稱為「臍帶繞頸」。
- 三、臀位生產：是指胎兒以臀部（buttocks，breech）為先露部位；又可分為完全（complete），直腿（frank），足式（footling）及膝式（kneeling）等4種型式。
- 四、病史詢問應包含羊水是否有胎便、胎兒數目及週數。

註2>

如已見臍帶脫垂，可考慮將手置入產道內，並以手指撐高胎兒生露部位，避免臍帶受到壓迫。

註3>

若無法解除臍帶繞頸，若狀況危急，可考慮將2處夾住，由中間剪斷臍帶後，儘速協助產出新生兒。

註4>

- 一、**P**必要時考慮*氣管內管插管（依「A1成人氣管內管插管」）。
- 二、若有呼吸窘迫，給予高濃度氧氣治療。
- 三、考慮建立暢通的靜脈路徑，給予靜脈注射乳酸林格氏液或N/S。